Test SSE

Niveau : DES
Genere le 14 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

Test SSE

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Épidémiologie et Introduction

L'épidémiologie, discipline fondamentale en santé publique, constitue la pierre angulaire de la compréhension des maladies, de leur distribution, de leurs déterminants et de leur évolution au sein des populations. En dermatologie, une discipline vaste et complexe, l'application des principes épidémiologiques est essentielle pour appréhender la charge des affections cutanées, orienter les stratégies de prévention, optimiser le diagnostic et évaluer l'efficacité des interventions thérapeutiques. Ce chapitre introductif vise à poser les bases conceptuelles de l'épidémiologie et à illustrer son importance à travers des exemples concrets tirés de la pathologie dermatologique.

Principes Fondamentaux de l'Épidémiologie

L'épidémiologie repose sur un ensemble de définitions statistiques et de principes méthodologiques rigoureux permettant de quantifier et d'analyser les phénomènes de santé.

Définitions Statistiques Clés

Plusieurs termes sont essentiels pour caractériser la survenue et la persistance des maladies dans une population (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017) :

- **Prévalence** : Représente le nombre total de cas d'une maladie donnée à un instant T ou sur une période donnée, rapporté à la population totale à risque. Elle est le plus souvent exprimée en pourcentage. La prévalence reflète la charge globale d'une maladie dans une population (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).
- **Incidence** : Mesure le nombre de nouveaux cas d'une maladie survenant au sein d'une population à risque pendant une période spécifiée. Elle est également fréquemment exprimée en pourcentage.

* L'**incidence cumulative** est exprimée sur une période de temps donnée.

* Le **taux d'incidence** correspond à l'incidence cumulative divisée par la durée de la période considérée (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017). L'incidence est cruciale pour évaluer la vitesse d'apparition d'une maladie et l'efficacité des mesures préventives.

- **Précision (Fiabilité)** : Décrit la cohérence avec laquelle les mesures répétées d'un test produisent des résultats similaires. Une mesure est précise si elle est reproductible (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).
- **Validité (Exactitude)** : Indique à quel point le résultat d'un test se rapproche de la "vérité" ou de la valeur réelle. Une mesure est valide si elle est exacte (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).

Calculs et Tables 2x2

L'analyse des données épidémiologiques implique fréquemment l'utilisation de tables de contingence 2x2, particulièrement utiles pour évaluer l'association entre une exposition et un résultat, ou pour caractériser la performance d'un test diagnostique (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).

Dans une table 2x2, on identifie généralement :

- **Exposition** : Les caractéristiques de base de la population étudiée. Cela peut être une intervention (par exemple, administration d'un médicament, session éducative), l'évaluation d'un risque (par exemple, tabagisme), ou, dans les études sur la précision des tests diagnostiques, les résultats du test lui-même.
- **Résultat (Outcome)** : Ce qui se produit pendant l'étude. Il peut s'agir d'une réponse à une intervention, du développement d'une maladie après exposition, ou, pour les études sur la précision des tests diagnostiques, la présence ou l'absence réelle de la maladie (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).

À partir de ces tables, plusieurs mesures de performance des tests diagnostiques peuvent être calculées :

- **Sensibilité** : La proportion de résultats positifs correctement identifiés. Elle est calculée comme a / (a + c), où 'a' représente les vrais positifs et 'c' les faux négatifs. Une sensibilité élevée signifie que si le test est négatif, la maladie est très probablement absente, car il y a très peu de faux négatifs (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).
- **Spécificité** : La proportion de résultats négatifs correctement identifiés. Elle est calculée comme d / (b + d), où 'd' représente les vrais négatifs et 'b' les faux positifs. Une spécificité élevée signifie que si le test est positif, la maladie est très probablement présente, car il y a très peu de faux positifs (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).
- **Valeur Prédictive Positive (VPP)** : La probabilité qu'une personne ayant un résultat de test positif soit réellement atteinte de la maladie. Elle est calculée comme a / (a + b). La VPP est plus susceptible d'être élevée pour les maladies à forte prévalence (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).
- **Valeur Prédictive Négative (VPN)** : La probabilité qu'une personne ayant un résultat de test négatif ne soit pas atteinte de la maladie. Elle est calculée comme c / (c + d). La VPN est plus susceptible d'être faible pour les maladies à forte prévalence (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).

Hypothèses et Erreurs Statistiques

Dans la recherche épidémiologique, l'**hypothèse nulle** est l'hypothèse de départ selon laquelle il n'y a pas de différence entre les groupes étudiés. Après des tests statistiques appropriés, cette hypothèse peut être rejetée ou acceptée (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).

- Une **erreur de type I (faux positif)** est le rejet incorrect d'une hypothèse nulle vraie. Le taux d'erreur de type I est appelé le niveau alpha, souvent fixé à 0,05 (ce qui

correspond à un taux de faux positifs de 5 %). Si la p-value calculée à partir des données est inférieure ou égale au niveau alpha, le résultat est considéré comme significatif et l'hypothèse nulle est rejetée (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).

• Une **erreur de type II (faux négatif)** est l'acceptation incorrecte d'une hypothèse nulle fausse. Le taux d'erreur de type II est appelé bêta, et est lié à la **puissance du test** (puissance = 1 - bêta). Plus la puissance du test est élevée, moins le test est susceptible de produire un faux négatif. La puissance d'un test est fréquemment augmentée en augmentant le nombre de sujets testés (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).

Types d'Études Épidémiologiques

La conception de l'étude est cruciale pour la validité des conclusions épidémiologiques. Les principaux types d'études incluent les études cas-témoins, les études de cohorte et les essais contrôlés randomisés (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).

Études Cas-Témoins

Ces études observationnelles rétrospectives identifient des patients présentant un résultat connu (par exemple, une maladie) et les comparent à un groupe de témoins sans ce résultat, afin de rechercher des différences en termes d'exposition à un facteur suspecté (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).

• **Exemple** : Identifier des patients atteints d'insuffisance rénale terminale avec une fibrose systémique néphrogénique (résultat connu) et un groupe de patients atteints d'insuffisance rénale terminale sans fibrose systémique néphrogénique, puis rechercher une différence entre les deux groupes concernant l'exposition à un certain type d'agent de contraste IRM (exposition suspectée) (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).

• **Avantages** : Moins coûteuses et plus rapides à réaliser que les études de cohorte ou les essais contrôlés randomisés, car elles sont rétrospectives. Elles sont particulièrement utiles pour étudier les maladies rares, car il faudrait beaucoup de temps pour recruter suffisamment de patients atteints de maladies rares dans des études de cohorte prospectives ou des essais contrôlés randomisés (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).

• Un **odds ratio** peut être calculé, qui identifie l'ampleur du risque ou de la protection conférée par l'exposition. Si l'intervalle de confiance est <1, l'exposition est protectrice ; s'il inclut 1, il n'y a pas d'effet discernable ; s'il est >1, il y a un risque accru (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).

Études de Cohorte

Les études de cohorte sont des études observationnelles où deux populations sont identifiées et séparées en fonction de leur exposition à une variable d'intérêt (groupes

exposés et non exposés), puis comparées pour voir s'il existe une différence en termes de risque de développer un résultat d'intérêt (par exemple, une maladie) (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).

- **Prospectives** : Le statut d'exposition est identifié avant la manifestation de la maladie.

* **Exemple** : Identifier deux groupes de personnes appariées à tous égards (revenu, statut socio-économique, etc.), sauf qu'un groupe utilise fréquemment des lits de bronzage (exposition ; également appelée variable indépendante). Ensuite, surveiller ces groupes au fil du temps pour voir si les deux groupes ont des taux de cancer de la peau différents (maladie ou résultat ; également appelée variable dépendante) (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).

* Le **risque relatif** peut être calculé. Si l'intervalle de confiance est <1, l'exposition est protectrice ; s'il inclut 1, il n'y a pas d'effet discernable ; s'il est >1, il y a un risque accru (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).

- **Rétrospectives** : Les données sur l'exposition sont obtenues à partir des dossiers médicaux, et les dossiers sont suivis pour observer les résultats.

* **Exemple** : Récupérer toutes les biopsies de naevi avec atypie cytologique sévère et rechercher l'incidence de nouveaux mélanomes documentés 10 ans après le diagnostic (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).

* Le risque relatif peut également être calculé (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).

Essais Contrôlés Randomisés (ECR)

Les ECR sont des études interventionnelles où les participants sont assignés aléatoirement à un groupe de traitement (recevant le médicament ou l'intervention étudiée) ou à un groupe témoin (ne recevant pas l'intervention). Les deux groupes sont ensuite comparés pour voir s'il existe une différence dans les résultats (par exemple, contrôle de la maladie, taux de mortalité, etc.) (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).

- Ils sont considérés comme l'étalon-or des essais cliniques, car la randomisation minimise le biais de sélection et les variables potentiellement confondantes (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).
- **Exemple** : Des patients atteints de délire de parasitose sont assignés aléatoirement à recevoir soit un nouveau médicament expérimental (groupe d'intervention), soit un placebo (groupe témoin). Ils sont ensuite comparés pour voir s'il y a une différence dans les résultats (Housholder, Alikhan et Hocker, 2017).

Épidémiologie des Affections Dermatologiques Spécifiques

L'application de ces principes épidémiologiques est cruciale pour comprendre la distribution et les déterminants des maladies cutanées.

Maladies Infectieuses Éruptives

L'épidémiologie joue un rôle majeur dans la gestion des maladies infectieuses éruptives, notamment chez l'enfant. Pour la rougeole, la rubéole, le mégalérythème épidémique, l'exanthème subit, la mononucléose infectieuse, la scarlatine, la maladie de Kawasaki et la varicelle, la connaissance de l'épidémiologie est un objectif de rang A ou B dans les connaissances du DES (Dermatologie, 2022).

- **Varicelle** : C'est la maladie éruptive la plus contagieuse, avec une

Présentation Clinique

La présentation clinique du syndrome de Stevens-Johnson (SJS) et de la nécrolyse épidermique toxique (TEN), également connue sous le nom de syndrome de Lyell, est caractérisée par une éruption cutanée aiguë et sévère, représentant un continuum de gravité des réactions médicamenteuses cutanées graves (SCARs). Ces entités se distinguent principalement par l'étendue de la surface corporelle atteinte par le décollement épidermique (Mann, Handbook of Dermatology).

Lésions Cutanées Initiales

Les lésions cutanées initiales du SJS/TEN sont souvent peu définies et se manifestent par des macules érythémateuses, d'aspect sombre ou purpurique, ou des lésions cibles atypiques planes (non palpables, non surélevées) de tailles et de formes variées (Alikhan et Hocker, 2e éd.). Ces macules peuvent présenter un centre sombre ou des bulles entourées d'un érythème, créant ainsi deux zones de couleur distinctes, contrairement aux lésions cibles classiques de l'érythème polymorphe qui en comportent trois (Mann, Handbook of Dermatology). L'apparition de ces lésions est généralement rapide, survenant typiquement 1 à 2 semaines après l'initiation du médicament causal, bien que pour les anticonvulsivants, cela puisse être plus tardif, dans les deux premiers mois (Alikhan et Hocker, 2e éd.).

Évolution et Distribution Topographique des Lésions

Les macules initiales ont une tendance rapide à la confluence, évoluant en quelques heures à quelques jours vers une nécrose épidermique pleine épaisseur (Alikhan et Hocker, 2e éd.). Les macules rouge sombre acquièrent alors une teinte grise, prélude à la formation de bulles flasques (Alikhan et Hocker, 2e éd.). La distribution des lésions débute généralement sur le tronc, puis s'étend au cou, au visage et aux extrémités supérieures proximales (Alikhan et Hocker, 2e éd.). Contrairement à l'érythème polymorphe, les extrémités distales sont largement épargnées dans le SJS/TEN (Alikhan et Hocker, 2e éd.). Cependant, le décollement cutané peut survenir dans les zones de pression, telles que les paumes et les plantes (Mann, Handbook of Dermatology). Les zones dénudées sont souvent suintantes et de couleur rouge foncé (Mann, Handbook of Dermatology).

Signes Cutanés Spécifiques

Deux signes cliniques majeurs sont caractéristiques du SJS/TEN et témoignent du clivage dermo-épidermique :

- **Signe de Nikolsky positif :** Une pression tangentielle appliquée sur la peau apparemment saine ou érythémateuse induit un clivage dermo-épidermique, entraînant un décollement de l'épiderme (Alikhan et Hocker, 2e éd.). Ce phénomène

peut donner à la peau un aspect de "papier froissé" (Mann, Handbook of Dermatology).

• **Signe d'Asboe-Hansen positif :** Une pression verticale appliquée sur le sommet d'une bulle existante provoque son extension vers la peau adjacente non encore décollée (Alikhan et Hocker, 2e éd.). Ce signe est également observé dans d'autres dermatoses bulleuses telles que le pemphigus, la pemphigoïde bulleuse, la dermatite herpétiforme, l'épidermolyse bulleuse acquise, la pemphigoïde cicatricielle et certaines dermatoses bulleuses médicamenteuses (Mann, Handbook of Dermatology).

Atteintes Muqueuses

L'atteinte des muqueuses est une caractéristique constante et souvent sévère du SJS/TEN, pouvant concerner de multiples sites. Les muqueuses buccale et labiale sont fréquemment touchées, mais l'atteinte peut s'étendre à l'urètre, au tractus gastro-intestinal, à la vulve, à l'anus, aux yeux et à l'arbre trachéo-bronchique (Mann, Handbook of Dermatology). Ces lésions muqueuses peuvent être extrêmement douloureuses et entraîner des complications fonctionnelles importantes, telles que des difficultés d'alimentation, de miction ou des problèmes respiratoires.

Classification Selon l'Étendue du Décollement Épidermique

Le SJS et la TEN sont considérés comme les deux extrêmes d'un même spectre de maladie, classifiés en fonction du pourcentage de surface corporelle totale (SCT) affectée par le décollement épidermique (Mann, Handbook of Dermatology) :

• **Syndrome de Stevens-Johnson (SJS) :** Le décollement épidermique concerne moins de 10 % de la SCT (Mann, Handbook of Dermatology).

• **SJS/TEN (overlap) :** Le décollement épidermique est compris entre 10 % et 30 % de la SCT (Mann, Handbook of Dermatology).

• **Nécrolyse Épidermique Toxique (TEN ou syndrome de Lyell) :** Le décollement épidermique affecte plus de 30 % de la SCT (Mann, Handbook of Dermatology).

Diagnostic Différentiel Clinique avec l'Érythème Polymorphe (EM)

Une distinction clinique fiable entre le SJS/TEN et l'érythème polymorphe (EM) est cruciale en raison de leurs étiologies et pronostics différents. L'EM est principalement déclenché par des infections, notamment le virus Herpes simplex (HSV) dans 90 % des cas, ou *Mycoplasma pneumoniae* pour l'EM majeur, et moins fréquemment par des médicaments (<10%) (Alikhan et Hocker, 2e éd.).

Les caractéristiques distinctives de l'EM incluent (Alikhan et Hocker, 2e éd.) :

• **Lésions cibles typiques :** L'EM se caractérise par des lésions cibles "classiques" bien délimitées, comportant trois zones : un centre sombre, vésiculeux ou nécrotique, un anneau périphérique pâle et œdémateux surélevé, et un anneau externe d'érythème maculaire.

- **Lésions cibles atypiques papuleuses :** Ces lésions sont surélevées et palpables, avec seulement deux zones et une bordure périphérique mal définie.
- **Absence de lésions cibles atypiques maculaires :** Contrairement au SJS/TEN, l'EM ne présente pas de lésions cibles atypiques maculaires (non palpables, non surélevées).
- **Distribution acrofaciale :** L'EM favorise le visage et les extrémités distales (membres supérieurs plus que les membres inférieurs), en particulier le dos des mains et les avant-bras.
- **Atteinte muqueuse :** L'EM mineur présente une atteinte muqueuse minimale, tandis que l'EM majeur peut s'accompagner d'une atteinte muqueuse sévère et de symptômes systémiques (fièvre, arthralgies), principalement au niveau de la muqueuse buccale et des lèvres (Alikhan et Hocker, 2e éd.).

La présence de lésions cibles surélevées/papuleuses et une distribution acrofaciale permettent une distinction fiable de l'EM par rapport au SJS/TEN (Alikhan et Hocker, 2e éd.).

Bibliographie

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• Sekulic et al. - 2017 - Long-term safety and efficacy of vismodegib in patients with advanced basal cell carcinoma final up

• dermatology handbook compressed-compressed

• margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical

• Dummer et al. - 2016 - The 12-month analysis from Basal Cell Carcinoma Outcomes with LDE225 Treatment (BOLT) A phase II, r

• Hauschild et al. - 2012 - Dabrafenib in BRAF-mutated metastatic melanoma a multicentre, open-label, phase 3 randomised contro